

Câncer de mama · rastreo e biópsia

Nódulo suspeito ou mamografia alterada exige diagnóstico histológico por core biopsy. Receptores (RE/RP/HER2) e estágio guiam cirurgia, sistêmico e radioterapia.

Rastreo

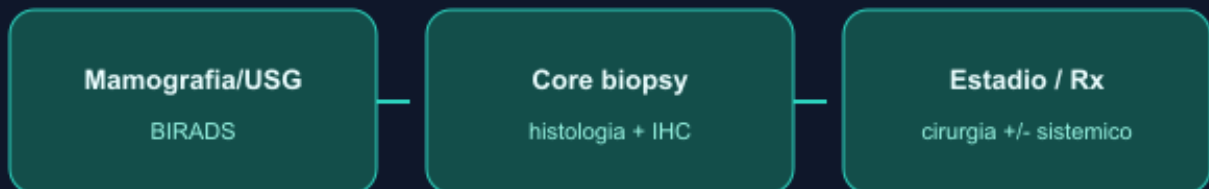
Lembre - Rastreo

Mamografia bienal tipicamente 50–69 anos no SUS (MS); sociedades podem sugerir início aos 40–45. Alto risco (BRCA/familiar): protocolo específico + RNM.

Não opere no escuro: histologia antes da conduta definitiva sempre que possível.

Nodulo / mamografia

Imagem -> biópsia -> estadiar



Conduta

- BIRADS 4–5: biópsia; 3: controle; 0: imagem adicional
- Cirurgia conservadora + RT se elegível; mastectomia conforme extensão/desejo
- Axila: biópsia de sentinela se clinicamente negativa
- Adjuvância: hormônio se RE+; anti-HER2 se HER2+; QT conforme risco

Sinais de alarme clínicos

Achado | Conduta

Nódulo duro fixo | Imagem + biópsia

Retração/pele em casca de laranja | Urgente mastologia

Secreção sanguinolenta unilateral | Investigar ducto/papiloma/Ca

Linfonodo axilar | Estadiar; biópsia

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

PAAF negativa não exclui câncer — prefira core. Gestação: massa suspeita também se biópsia; não atrase por 'esperar o parto' sem avaliação.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1